

1. Introducción y relevancia clínica

La **adenoiditis** es la **inflamación aguda o crónica del tejido adenoideo** (amígdala faríngea), localizada en la parte posterior de la nasofaringe.

Forma parte del **anillo linfático de Waldeyer**, junto con las amígdalas palatinas y linguales, desempeñando un rol inmunológico importante en la infancia.

La **adenoiditis crónica** y la **hipertrofia adenoidea persistente** son causas frecuentes de:

- **Obstrucción nasal crónica,**
- **Respiración bucal habitual,**
- **Otitis media serosa** (por disfunción de la trompa de Eustaquio), y
- **Trastornos del sueño** como el **síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño infantil (SAHOS).**

Relevancia clínica

- La **hipertrofia adenoidea** es una de las causas más comunes de **obstrucción nasal en niños.**
- El **respirador bucal crónico** puede generar alteraciones **dentofaciales, fonatorias y del sueño**, por lo que su detección y manejo oportuno son esenciales.
- En Chile, la **adenoidectomía** es una de las cirugías otorrinolaringológicas más frecuentes.
- Este tema es clásico en el **EUNACOM**, tanto por su presentación pediátrica común como por la necesidad de reconocer los criterios de **derivación a ORL.**

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Función de las adenoides

Las adenoides son un **tejido linfoide** situado en la bóveda faríngea (nasofaringe posterior), cuyo rol es:

- Captar antígenos inhalados u orales.
- Activar linfocitos T y B locales.
- Favorecer la producción de IgA secretora, esencial en la inmunidad mucosa.

En la infancia, este tejido es **hiperfuncionante** (máximo tamaño entre los 3 y 7 años) y posteriormente **involuciona** hacia la adolescencia.

2.2 Fisiopatología de la adenoiditis

1. La infección de vías respiratorias superiores (virus o bacterias) genera **edema e hipertrofia adenoidea**.
 2. La obstrucción de la **trompa de Eustaquio** lleva a **otitis media con efusión o otitis media aguda recurrente**.
 3. En cuadros crónicos, la inflamación persistente produce **hipertrofia mantenida y respiración bucal habitual**.
 4. La obstrucción crónica provoca alteraciones en la ventilación nasal, favoreciendo **ronquido, apnea del sueño y deformidades faciales** ("facies adenoidea").
-

2.3 Etiología y agentes

- **Viral (agudo)**: Adenovirus, rinovirus, coronavirus, virus influenza, virus sincicial respiratorio.
 - **Bacteriano (crónico o recurrente)**: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae no tipificable*, *Moraxella catarrhalis*, *Staphylococcus aureus*.
-

2.4 Factores de riesgo

- Alergia respiratoria crónica.
- Exposición al humo del tabaco.
- Guardería o escolarización precoz.

- Infecciones respiratorias frecuentes.
 - Hipertrofia amigdalar coexistente.
 - Reflujo gastroesofágico.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Adenoiditis aguda

- **Síntomas:**
 - Rinorrea mucopurulenta posterior, obstrucción nasal, fiebre moderada.
 - Voz nasal cerrada (“voz gangosa”), halitosis.
 - Tos nocturna por goteo posterior.
 - A menudo asociada a faringoamigdalitis o otitis media aguda.
 - **Signos físicos:**
 - Mucosa faríngea eritematosa, secreción posterior.
 - Adenopatías cervicales reactivas.
 - Fiebre, malestar general.
-

3.2 Adenoiditis crónica / Hipertrofia adenoidea

- **Síntomas predominantes:**
 - **Obstrucción nasal crónica bilateral.**
 - **Respiración bucal habitual** (niño con boca abierta).
 - **Ronquido y apneas durante el sueño.**
 - **Hiponasalidad** (voz apagada).

- **Otitis media serosa o recurrente.**
 - Tos nocturna persistente.
 - Halitosis.
 - **Signos característicos del respirador bucal crónico:**
 - Boca entreabierta permanentemente.
 - Labio superior corto o evertido.
 - Narinas pequeñas y poco utilizadas.
 - Ojeras marcadas (“facies adenoidea”).
 - Paladar ojival (alto y estrecho).
 - Maloclusión dental (mordida abierta o cruzada).
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Patología	Características diferenciales
Rinitis alérgica	Rinorrea acuosa, estornudos, prurito nasal, sin fiebre.
Sinusitis crónica	Dolor facial, cefalea, secreción purulenta persistente.
Poliposis nasal	Masa blanda en meato medio; más frecuente en adolescentes con asma o fibrosis quística.
Desviación del tabique nasal	Obstrucción unilateral fija.
Tumor nasofaríngeo (raro en niños)	Epistaxis recurrente, obstrucción nasal unilateral, otitis serosa unilateral persistente.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

- En atención primaria, se realiza **por la historia y el examen físico** (voz nasal, respiración bucal, ronquido, otitis media recurrente).
- En casos persistentes o obstructivos, la confirmación requiere **evaluación por ORL**.

4.2 Exámenes complementarios

Examen	Utilidad
Nasofibroscopía flexible (ORL)	Método de elección. Permite visualizar directamente el tamaño y grado de obstrucción adenoidea (>70% del coanal = significativo).
Radiografía lateral de cavum (perfil nasofaríngeo)	Alternativa si no hay nasofibroscopía. Evalúa columna aérea posterior. Menos sensible.
Audiometría y/o timpanometría	Si hay sospecha de disfunción tubárica u otitis media serosa.
Poligrafía respiratoria o polisomnografía	En sospecha de apnea obstructiva del sueño.

4.3 Criterios diagnósticos (MINSAL / SOCHIORL)

Se diagnostica **hipertrofia adenoidea clínicamente significativa** si se cumplen ≥ 2 de los siguientes:

1. Obstrucción nasal persistente (>3 meses).

2. Ronquido o apneas observadas durante el sueño.
 3. Otitis media serosa o recurrente.
 4. Respiración bucal crónica con voz nasal.
 5. Confirmación endoscópica o radiológica de obstrucción >70%.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Tratamiento médico inicial

Indicaciones: adenoiditis aguda o hipertrofia leve/moderada sin apnea ni otitis serosa significativa.

Medidas generales:

- Higiene nasal con suero fisiológico o lavados isotónicos.
- Evitar exposición a tabaco o polvo.
- Control de alergias (si presentes).
- Dormir con ligera elevación cefálica.

Farmacoterapia:

- **Antibióticos** solo en adenoiditis aguda bacteriana (fiebre alta, secreción purulenta):
 - Amoxicilina 80–90 mg/kg/día por 10 días o amoxicilina/ácido clavulánico.
 - **Corticoides nasales tópicos** (mometasona, budesonida) en casos de hipertrofia leve y rinitis concomitante.
 - **Antihistamínicos**: solo si hay componente alérgico.
 - **Analgesia y antitérmicos** (paracetamol o ibuprofeno).
-

5.2 Tratamiento quirúrgico: Adenoidectomía

Indicaciones según MINSAL / SOCHIORL:

1. Obstrucción nasal severa con apnea del sueño confirmada o sospechada.
2. Otitis media serosa o recurrente asociada a disfunción tubárica.
3. Rinorrea y tos nocturna persistente >3 meses refractaria a tratamiento médico.
4. Retraso ponderal o del crecimiento secundario a trastornos del sueño.
5. Alteraciones dentofaciales o del lenguaje secundarias a respiración bucal crónica.
6. Adenoiditis recurrente ≥ 4 episodios/año.

Contraindicaciones relativas:

- Infección respiratoria activa (posponer cirugía).
- Trastornos hemorrágicos no corregidos.

Técnica quirúrgica:

- Se realiza bajo **anestesia general**, por vía transoral.
- Extracción del tejido adenoideo con **cureta, microdebridador o electrocauterio**.
- Sangrado controlado por compresión o cauterización.
- Duración aproximada: 20–30 minutos.

Frecuentemente se asocia a amigdalectomía o colocación de **tubos de ventilación timpánica** si hay otitis media serosa.

5.3 Cuidados postoperatorios

- Dieta blanda y fría por 48 horas.
- Control del dolor con paracetamol o ibuprofeno.
- Evitar ejercicio intenso 7–10 días.
- Control ORL en 10–14 días.
- Reincorporación escolar tras 5–7 días si evolución normal.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones de la enfermedad no tratada

- **Otitis media recurrente** o persistente.
- **Apnea obstructiva del sueño infantil** → hipoxemia, trastorno del crecimiento, déficit cognitivo o de atención.
- **Trastornos dentofaciales** (paladar ojival, mordida abierta, maloclusión).
- **Alteraciones del lenguaje y voz hiponasal.**
- **Facies adenoidea.**

6.2 Complicaciones de la adenoidectomía

Complicación	Frecuencia	Comentarios
Hemorragia	1–3%	Inmediata o diferida; requiere control ORL.
Dolor y fiebre leve	Frecuente	Autolimitado.
Insuficiencia velofaríngea transitoria	Rara	Hipernasalidad; usualmente reversible.
Recidiva del tejido adenoideo	5–10%	En niños pequeños (<5 años).

6.3 Pronóstico

- Excelente con tratamiento quirúrgico adecuado.

- Mejoría significativa de la **respiración nasal, sueño y calidad de vida**.
 - Reducción de episodios de otitis media y de infecciones respiratorias altas.
 - La recidiva es poco frecuente y generalmente leve.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Niño con respiración bucal crónica, ronquido y otitis recurrente = sospechar hipertrofia adenoidea.
 2. La **nasofibroscopía** es el **método diagnóstico de elección** para evaluar tamaño y obstrucción.
 3. **Corticoides nasales** pueden reducir el tamaño adenoideo leve/moderado.
 4. En casos obstructivos o refractarios, la **adenoidectomía** es el tratamiento definitivo.
 5. La **apnea obstructiva del sueño** infantil es una indicación quirúrgica prioritaria.
 6. La **facies adenoidea** y los **trastornos dentales** son reversibles si se trata precozmente.
 7. La cirugía **no afecta la inmunidad** significativamente, ya que las adenoides involucionan fisiológicamente con la edad.
-

Errores comunes

- Prescribir antibióticos repetidos sin confirmar causa obstructiva.
- No sospechar **otitis media serosa** en niños con hipoacusia o lenguaje retardado.
- Indicar adenoidectomía sin descartar **rinitis alérgica**.
- Operar durante infección activa.
- No evaluar ronquido o apnea antes de decidir cirugía.

- Olvidar que la **adenoiditis crónica puede coexistir con hipertrofia amigdalar**.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **adenoiditis** es la inflamación de la amígdala faríngea; la **hipertrofia adenoidea** causa **obstrucción nasal y respiración bucal crónica**.
2. Síntomas típicos: **ronquido, voz nasal, otitis media recurrente, facies adenoidea y apnea del sueño**.
3. Diagnóstico clínico, confirmado por **nasofibroscopía o radiografía de cavum**.
4. Tratamiento inicial médico: **lavados nasales, corticoides tópicos, control de alergias y antibióticos si hay infección aguda**.
5. **Adenoidectomía** indicada en casos obstructivos, recurrentes o refractarios al tratamiento médico.
6. Complicaciones de la no intervención: **otitis crónica, apnea del sueño y deformidades dentofaciales**.
7. Pronóstico excelente tras cirugía; la **recidiva es infrecuente** y el impacto inmunológico es mínimo.